

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ÍNDICE DE SEVERIDAD DEL INSOMNIO (ISI)

Insomnia Severity Index (Morin, 1993; Bastien, Vallières & Morin, 2001) · Adaptación Española (Fernández-Mendoza et al., 2012)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Índice de Severidad del Insomnio (Insomnia Severity Index, ISI)
Sigla / Acrónimo	ISI
Autoría original	Charles M. Morin (Université Laval, Québec, Canadá, 1993; Bastien et al., 2001)
Adaptación en español	Fernández-Mendoza et al. (2012, Odisea/Sleep Med); Sierra et al. (2008, Rev Mex Psicol)
Constructo evaluado	Naturaleza, severidad e impacto funcional del insomnio crónico según criterios DSM-IV/DSM-5
Población diana	Adolescentes y adultos (≥ 16 años) con quejas de insomnio de conciliación, mantenimiento o despertar precoz
Tiempo de aplicación	3 a 5 minutos (autoadministrado)
Estructura y formato	7 ítems evaluados en escala Likert de 5 opciones (0 = ninguno/nada, 4 = muy severo/mucho)
Condiciones de uso	Uso clínico y académico libre no comercial citando la autoría original de Morin (1993)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El insomnio crónico no es simplemente una alteración cuantitativa de las horas de sueño, sino un trastorno cognitivo-conductual caracterizado por un estado persistente de hiperactivación neurobiológica (hiperarousal psicofisiológico y autonómico). Según el modelo de las “3P” de Spielman (factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes) y el modelo cognitivo de Morin, el mantenimiento del insomnio está mediado por rumiaciones disfuncionales sobre las consecuencias del no dormir, conductas de evitación y monitorización atencional excesiva de los procesos corporales.

El ISI fue diseñado específicamente como un instrumento de cribado, diagnóstico y monitorización de respuesta terapéutica a la Terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio (TCC-I) y a intervenciones farmacológicas. Abarca tanto las quejas nocturnas (dificultad para iniciar o mantener el sueño) como las consecuencias diurnas (deterioro funcional, preocupación, angustia y pérdida de satisfacción con el sueño), alineándose con los criterios nosológicos de la ICSD-3 y DSM-5.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Ítem	Aspecto Clínico Evaluado	Rango	Relevancia Diagnóstica (Últimas 2 Semanas)
1a	Dificultad para conciliar el sueño	0 - 4	Insomnio de conciliación (latencia > 30 min, hiperarousal inicial)
1b	Dificultad para mantener el sueño	0 - 4	Insomnio de mantenimiento (despertares frecuentes nocturnos)
1c	Problemas por despertar muy temprano	0 - 4	Despertar precoz matutino (frecuente en cuadros depresivos)
2	Satisfacción con el patrón actual de sueño	0 - 4	Percepción subjetiva de calidad y descanso restaurador
3	Interferencia en funcionamiento diurno	0 - 4	Rendimiento laboral, fatiga, memoria y concentración
4	Notabilidad / Perceptibilidad social	0 - 4	Grado en que otros perciben el deterioro por falta de sueño
5	Preocupación / Angustia por el insomnio	0 - 4	Carga emocional, ansiedad anticipatoria y distrés cognitivo

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA

Consistencia interna	Excelente consistencia global; alfa de Cronbach $\alpha = 0.90$ en muestras clínicas y $\alpha = 0.82$ en población comunitaria (Fernández-Mendoza et al., 2012).
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 2 semanas: $r = 0.86 - 0.89$, demostrando solidez psicométrica y reactividad adecuada tras intervenciones activas.
Validez convergente	Correlación robusta con el PSQI ($r = 0.77 - 0.80$), con la Escala de Ansiedad de Beck ($r = 0.54$) y con diarios de sueño (latencia $r = 0.48$, eficiencia $r = -0.56$).
Estructura factorial	Estructura de 3 factores interrelacionados: Impacto/Preocupación, Severidad Nocturna y Satisfacción, agrupables en un factor general de segundo orden.
Sensibilidad al cambio	Disminución de ≥ 6 puntos indica mejoría clínica clínicamente significativa; disminución de ≥ 8 puntos o puntuación final < 8 define remisión terapéutica.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Marco temporal	El sujeto valora los síntomas experimentados durante las últimas dos semanas .
Puntuación directa	Cada uno de los 7 ítems se codifica de 0 a 4 puntos. La puntuación total es la suma aritmética directa de todos los ítems. Rango: 0 a 28 puntos .
Direccionalidad	Todos los ítems están formulados en sentido desfavorable (a mayor puntuación, mayor severidad del trastorno). No requiere inversión de ítems.
Tratamiento de nulos	Se permite como máximo 1 ítem sin responder ($< 15\%$), imputando la media de los 6 restantes. Si faltan ≥ 2 ítems, la prueba se invalida.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación	Percentil Aprox.	Categoría Diagnóstica	Significación Clínica y Acción Recomendada
0 - 7	$< \text{Pc } 50$	Sin Insomnio Clínico	Patrón de sueño dentro de límites normales. No requiere intervención.
8 - 14	$\text{Pc } 55 - \text{Pc } 75$	Insomnio Subclínico / Leve	Dificultades leves o transitorias. Pautas de higiene del sueño.
15 - 21	$\text{Pc } 80 - \text{Pc } 95$	Insomnio Clínico Moderado	Afectación clínica manifiesta. Indicada TCC-I o abordaje médico.
22 - 28	$> \text{Pc } 95$	Insomnio Clínico Severo	Deterioro grave funcional y psicofisiológico. Abordaje multimodal intensivo.

PUNTOS DE CORTE Y CRITERIOS DE RESPUESTA:

- **Población Comunitaria:** Punto de corte **ISI ≥ 10** (sensibilidad 86.1%, especificidad 87.7%) para detección precoz.
- **Población Clínica:** Punto de corte **ISI ≥ 15** para confirmar diagnóstico de insomnio clínicamente relevante (ICSD-3).
- **Criterio de Remisión:** Puntuación post-tratamiento < 8 puntos. Reducción ≥ 8 puntos refleja respuesta terapéutica excelente.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Cálculo del ISI Total: Evaluar puntuación global.

Paso 2: Si ISI 0 — 7: Descartar insomnio como causa primaria de malestar; explorar higiene ambiental.

Paso 3: Si ISI 8 — 14 (Subclínico): Proporcionar psicoeducación sobre el sueño, restricción de cafeína y regularidad horaria. Monitorear con diario de sueño durante 2 semanas.

Paso 4: Si ISI 15 — 21 (Clínico Moderado): Implementar TCC-I como tratamiento de primera línea (control de estímulos, restricción de tiempo en cama y reestructuración cognitiva). Si hay comorbilidad psiquiátrica (ansiedad/depresión), tratar el trastorno de base conjuntamente.

Paso 5: Si ISI 22 — 28 (Clínico Severo): Considerar farmacoterapia hipnótica a corto plazo ($\leq 2 - 4$ semanas) coadyuvante a TCC-I. Descartar apnea de sueño, síndrome de piernas inquietas o depresión mayor grave con ideación suicida.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO MULTIDISCIPLINAR

Identificación: Mujer de 39 años, abogada mercantilista, consulta por insomnio de conciliación y mantenimiento de 8 meses de evolución, iniciado tras una reestructuración corporativa. Uso diario de zolpidem 10 mg sin mejoría sostenida.

Evaluación Inicial: Puntuación ISI = **23 / 28** (Insomnio Clínico Severo). Ítems 1a = 4, 1b = 3, 2 = 4 (muy insatisfecha), 3 = 4 (deterioro cognitivo diurno marcado), 5 = 4 (angustia intensa ante la noche). BDI-II = 14 (depresión leve).

Plan de Intervención: Se inició protocolo de TCC-I de 6 sesiones: restricción del tiempo en cama a 6 horas (según diario de sueño con eficiencia del 62%), técnica de control de estímulos (levantarse de la cama si no duerme en 20 min) y desensibilización cognitiva. Retirada gradual programada de zolpidem.

Evolución: En la semana 8 posintervención, el ISI disminuyó a **6 / 28** (Remisión clínica, reducción de 17 puntos), con una eficiencia del sueño del 88% sin fármacos hipnóticos.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgo de Suicidio:

- **Riesgo Autolítico:** El insomnio severo persistente con despertar precoz e hiperarousal es un predictor independiente de ideación y conducta suicida; cribar activamente desesperanza.
- **Abuso de Fármacos:** Vigilar tolerancia, escalada de dosis y síntomas de rebote por benzodiacepinas o drogas Z.

Diagnóstico Diferencial:

- **Síndrome de Piernas Inquietas (SPI):** Disestesias vespertinas en extremidades aliviadas por el movimiento.
- **Trastornos del Ritmo Circadiano:** Síndrome de retraso de fase de sueño en jóvenes (conciliación tardía pero sueño normal si se les deja dormir).
- **Apnea de Sueño:** Microdespertares confundidos con insomnio de mantenimiento.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Bastien, C. H., Vallières, A., & Morin, C. M. (2001). Validation of the Insomnia Severity Index as an outcome measure for insomnia research. *Sleep Medicine*, 2(4), 297-307. [https://doi.org/10.1016/S1389-9457\(00\)00065-4](https://doi.org/10.1016/S1389-9457(00)00065-4)
- Fernández-Mendoza, J., Rodríguez-Muñoz, A., Vela-Bueno, A., Olavarrieta-Bernardino, S., Calhoun, S. L., Bixler, E. O., & Vgontzas, A. N. (2012). The Spanish version of the Insomnia Severity Index: A confirmatory factor analysis. *Sleep Medicine*, 13(2), 208-210. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2011.06.019>
- Morin, C. M. (1993). *Insomnia: Psychological assessment and management*. Guilford Press.
- Morin, C. M., Belleville, G., Bélanger, L., & Ivers, H. (2011). The Insomnia Severity Index: Psychometric indicators to detect insomnia cases and evaluate treatment response. *Sleep*, 34(5), 601-608. <https://doi.org/10.1093/sleep/34.5.601>